

35 - 06-PALPITATIONS - Pr. L. Bendriss

(0:07 - 1:28)

Bonjour, donc on va traiter en ce moment le cours sur des palpitations qui est une perception qui serait anormale et désagréable des battements cardiaques, donc ça va susciter l'intérêt de rechercher un trouble du rythme sous-jacent. Alors comme je vous le dis tout à l'heure, normalement quand votre cœur bat, vous ne le sentez pas, ça se fait d'une manière inconsciente et non-perspective, c'est-à-dire vous ne le sentez pas et vous ne le suivez pas, d'accord, si on veut dire ça passe en silence, mais dès que vous commencez à avoir une perception, déjà à la perception et qui serait déjà anormale cette perception et désagréable des battements cardiaques, on rentre dans la définition des palpitations, c'est une sensation des cœurs qui bat rapidement, c'est une impression, une autre impression que le cœur carrément peut s'arrêter. C'est des palpitations qui vont survenir dans différentes conditions, soit au repos, à l'effort, souvent dans des conditions de stress ou de fatigue, soit un début progressif ou carrément aiguë et brutal, ça peut durer de quelques secondes à plusieurs heures et peuvent être isolées ou s'associer à un tableau clinique qui va comporter une dyspnée, une douleur thoracique ou autre chose.

(1:32 - 3:06)

Donc à l'anamnèse ou l'interrogatoire, quand on a un patient qui vient pour palpitations, on a certaines choses à préciser pour pouvoir s'orienter vers la nature et l'étiologie du trouble d'urine, notamment le mode de début, progressif ou brutal, la fréquence de survenue, soit qu'il va vous dire je l'ai deux fois par jour, je l'ai quatre fois par semaine, puis la durée des crises, la perception des battements cardiaques, soit ça va être une régularité que va vous décrire le patient, soit qu'il va sentir des battements cardiaques irréguliers et grossièrement, vous avez trois grandes situations qu'on va détailler plus tard. Soit vous avez une perception des battements du cœur en rythme sinusal, comme vous savez le rythme sinusal c'est le rythme normal du cœur, c'est-à-dire c'est un rythme qui va émaner ou qui va prendre au départ du nœud sinusal qui est le pacemaker du cœur, c'est lui qui va entamer la dépolarisation et qui va s'en suivre par la suite par une activation de tout le myocarde ventriculaire. Puis deuxième cas de figure, c'est la perception d'irrégularité occasionnelle, c'est-à-dire que vous étiez dans un rythme sinusal normal et soudainement va sortir une systole qui va être extra de ces systoles normales, c'est-à-dire une systole qui va se revenir d'une manière beaucoup plus précoce que la systole normale et on va le voir un peu plus tard, soit que vous aurez comme troisième situation, une arythmie qui dit A, A c'est le contraire du rythme, c'est-à-dire que vous aurez un autre rythme autre que celui du rythme sinusal, c'est-à-dire que vous aurez un autre foyer qui va entamer la dépolarisation cardiaque.

(3:09 - 7:46)

Alors première situation, c'est perception des battements du cœur en rythme sinusal, c'est-à-dire que vous allez ressentir un rythme qui est normalement sinusal normal, alors je vous ai mis un cadran par rapport à un électrocardiogramme normal pour s'orienter par rapport à la base, vous aurez au tout début l'onde P qui est de petite amplitude, vous avez le complexe QRS de segment ST et l'onde T, vous avez un rythme, ça c'est sinusal parce que vous avez l'onde P qui est sinusal ici, puis vous avez une fréquence cardiaque ici, quand vous le calculez à partir de cette distance entre les complexes QRS, ça fait à peu près 50 battements par minute, et en bas vous avez ce qu'on appelle tachycardie sinusal, tachycardie c'est une accélération du rythme cardiaque mais toujours étant dans le rythme sinusal, donc vous regardez, vous avez pratiquement l'onde P, le QRS, ST et T, mais par contre vous avez un rythme qui est accéléré au lieu d'avoir par exemple 5 grands carreaux qui séparent les QRS, vous avez 3 petits carreaux, 3 grands carreaux qui séparent les QRS et vous aurez donc une fréquence cardiaque aux alentours à peu près de 120 battements par minute par rapport à une normale à 50 ou 60 battements par minute. Alors cette tachycardie sinusal serait due à une hyperactivité du système nerveux sympathique qui accélère, qui est une action, comme vous le savez, chronopositif, plus facilement on va ressentir cette tachycardie à la nuit parce qu'en principe dans la nuit la fréquence cardiaque baisse, et généralement c'est une accélération qui est bénigne, alors il n'y a pas généralement de pathologie cardiaque sous-jacente, ça pourrait être dû à toutes les situations, que ce soit une anémie, une déshydratation, une fièvre, une infection, tout ce que vous voulez. Alors deuxième cas de figure c'est perception d'irrégularité occasionnelle, c'est-à-dire vous étiez dans un rythme normal, alors vous regardez votre ECG, premier complexe QRS est normal, le deuxième il est normal, j'attends que j'aurai un troisième après pratiquement 4 ou 5 carreaux, mais j'ai au bout de 2 carreaux, j'ai quelque chose qui sort, c'est ce qu'on appelle une extra-systole, ça veut dire que c'est une systole qui est sortie avant la systole normale, c'est la répétition pour laquelle on va dire extra, elle est un petit peu en dehors de la systole normale, c'est ce qu'on appelle une extra-systole qui va être suivie parce qu'elle est sortie de manière précoce, elle va être suivie d'un repos compensateur qui serait dû aux périodes réfractaires, et ça c'est une extra-systole auriculaire, auriculaire c'est-à-dire qu'elle va naître au niveau des oreillettes, on pourrait avoir des extra-systoles jonctionnaires, c'est-à-dire au niveau de la jonction auriculaire ventriculaire comme des extra-systoles ventriculaires, alors ça serait dû à des battements ectopiques, le plus loin ils sont bénins, d'accord, et on sent toujours, le patient va vous décrire les choses comme suivant, je sens qu'il y avait une irrégularité, c'est-à-dire j'ai eu un battement cardiaque, c'est l'extra-systole, puis il manque un battement du cœur par la suite, d'accord, c'est le repos compensateur, donc il va vous donner l'impression que le cœur saute ou palpite, c'est-à-dire va sauter une systole auriculaire ordinaire.

Et puis dernier cas de figure, c'est arrhythmie, c'est-à-dire qu'on sort du rythme sinusal, donc on va avoir d'autres rythmes, donc c'est des débuts souvent brusques, ça pourrait être duré de quelques minutes ou plus, parfois il y a des facteurs déclenchants, notamment l'exercice. Là, dans ces arrhythmies, il faut toujours chercher là une pathologie cardiaque par exemple sous-

jacente, notamment la cardiopathie ischémique, quand vous avez une sténose coronaire qui va entraîner une ischémie myocardique, et ces troubles du rythme, on pourrait les avoir aux trois étages, c'est-à-dire l'étage atrial, au niveau des oreillettes, l'étage jonctionnel, au niveau de la jonction auriculaire ventriculaire, c'est-à-dire le nœud auriculaire ventriculaire et le faisceau de hisse, et puis vous avez des troubles du rythme à l'étage ventriculaire, soit le ventricule droit ou le ventricule gauche. Alors à l'étage atrial, il y a plusieurs troubles du rythme, nous avons notamment la fibrillation auriculaire flûtaire, je vous donne juste des exemples, mais c'est pas l'objectif du cours, c'est essentiellement de reconnaître quelles sont les arrhythmies.

À l'étage jonctionnel, on appelle tachycardie jonctionnée, puis à l'étage ventriculaire, c'est des tachycardies ventriculaires. Alors pour les tachycardies ventriculaires, c'est généralement des tachycardies avec un pronostic vital qui est mis en jeu à cause de l'inefficacité circulatoire, on peut facilement avoir un état de choc et une mort subite. Alors tout de suite, je vais vous montrer les exemples de ces tachycardies.

(7:49 - 8:18)

Donc voici les exemples de ces tachycardies ou ces arrhythmies, le but c'est pas d'interpréter le CG, mais juste un petit peu de reconnaître ce qu'ont les arrhythmies à l'étage auriculaire et à l'étage ventriculaire. Alors en haut, vous avez l'exemple de fibrillation auriculaire. Alors dans ce cadran de fibrillation auriculaire, juste la dérivation qui est en bas, c'est le CG normal, avec une flèche mauve qui vous indique l'onde P, qui est due à un rythme sinusale.

(8:19 - 9:53)

Et puis juste en haut, vous avez la disparition de l'onde P, qui est remplacée par une crémulation galanque isoélectrique qui serait due à des foyers ectopiques qui existent au niveau des oreillettes à partir desquels va naître la dépolarisation, donc on est dans une arrhythmie, donc on est loin du rythme sinusale, c'est ce qu'on appelle la fibrillation auriculaire. Alors en bas, tachycardie jonctionnelle, ça va naître au niveau de la jonction, donc vous allez comprendre tout de suite qu'il n'y aurait pas l'onde P, et puis vous aurez un rythme qui va être accéléré aux alentours de 200 battements par minute, c'est ce que vous avez dans la tachycardie jonctionnelle. Et puis, ces QRS regardifs sont fins, parce que c'est au niveau de la jonction et le faisceau du hyste, donc vous avez une dépolarisation qui va être spontanée des deux ventricules de manière synchrone, raison pour laquelle vous aurez un QRS fin.

Et puis en bas, vous avez la tachycardie ventriculaire, ça veut dire qu'elle est née au niveau de l'un des ventricules, automatiquement vous n'aurez pas l'onde de P, et c'est un trouble du rythme qui est rapide aux alentours de 150 jusqu'à 180 et 200. Et vous remarquez que les QRS sont larges, pourquoi? Parce que ça naît par exemple au niveau du ventricule droit, et pour qu'elle soit transmise au niveau du ventricule gauche, la dépolarisation va emprunter le réseau de Purkinier qui a une vitesse de conduction qui est longue, donc ça va prendre du temps et du coup le QRS

va être large. Alors le but de ces ECG, ce n'est pas de les interpréter, parce que vous n'êtes pas au stade d'interprétation d'ECG, mais juste un petit peu de reconnaître la différence entre les différentes arrêts.

Je vous remercie.